Mise au point sur le traitement des infections à *Clostridioides difficile* chez l'adulte

Jeu de diapositives réalisé par le groupe recommandation de la SPILF
le 09.02.2022
À partit des recommandations de l'European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Questions

- Quel est le meilleur traitement initial pour un premier épisode d'infection à *C. difficile*?
- Quel est le meilleur traitement pour une forme grave ou grave et compliquée?
- Quel est le meilleur traitement quand la voie orale est impossible?
- Quel est le meilleur traitement pour une forme réfractaire?
- Quel est le meilleur traitement en cas de récurrence?
- Quel est le meilleur traitement en cas de récurrence multiples?
- Quels facteurs pronostiques peuvent identifier les patients à risque de forme grave?
- Quels facteurs pronostiques peuvent identifier les patients à risque de récurrence?
- Existe-t-il une place pour la prophylaxie dans la prévention des infections à *C. difficile*?

Définition de l'infection à *C. difficile*

- Tableau clinique compatible + toxine libre par EIA* + pas d'autre cause évidente de diarrhée (≥ 3 selles molles (Bristol 6-7) en 24h)

OU

- Tableau clinique compatible + test PCR positif ou culture toxigénique positive

OU

- Colite pseudomembraneuse (diagnostic endoscopique et/ou anatomopathologique) + test toxigénique positif

*EIA: diagnostic immuno-enzymatique

Définitions des réponses au traitement

- L’évaluation de la réponse au traitement ne se fait pas avant le 3ème jour de traitement
- Forme réfractaire

  Absence de réponse au traitement après 3-5 jours
- Rechute

  Episode survenant dans les 8 semaines du 1er épisode après une réponse initiale au traitement
- Si nouvel épisode au delà de 8 semaines, il s’agit d’une nouvelle infection (récidive)

Définitions de la gravité

- Forme grave : au moins un des critères suivants
  - Fièvre > 38.5°C
  - Leucocytose > 15.10^9/L
  - Créatinine > 50% valeur de base
  - Si imagerie disponible: distension colique, infiltration de la graisse péri-colique, épaississement paroi colique
- Forme grave ET compliquée: au moins un des critères suivants
  - Hypotension, choc septique, élévation des lactates, iléus, mégacolon toxique, perforation intestinale, évolution fulminante

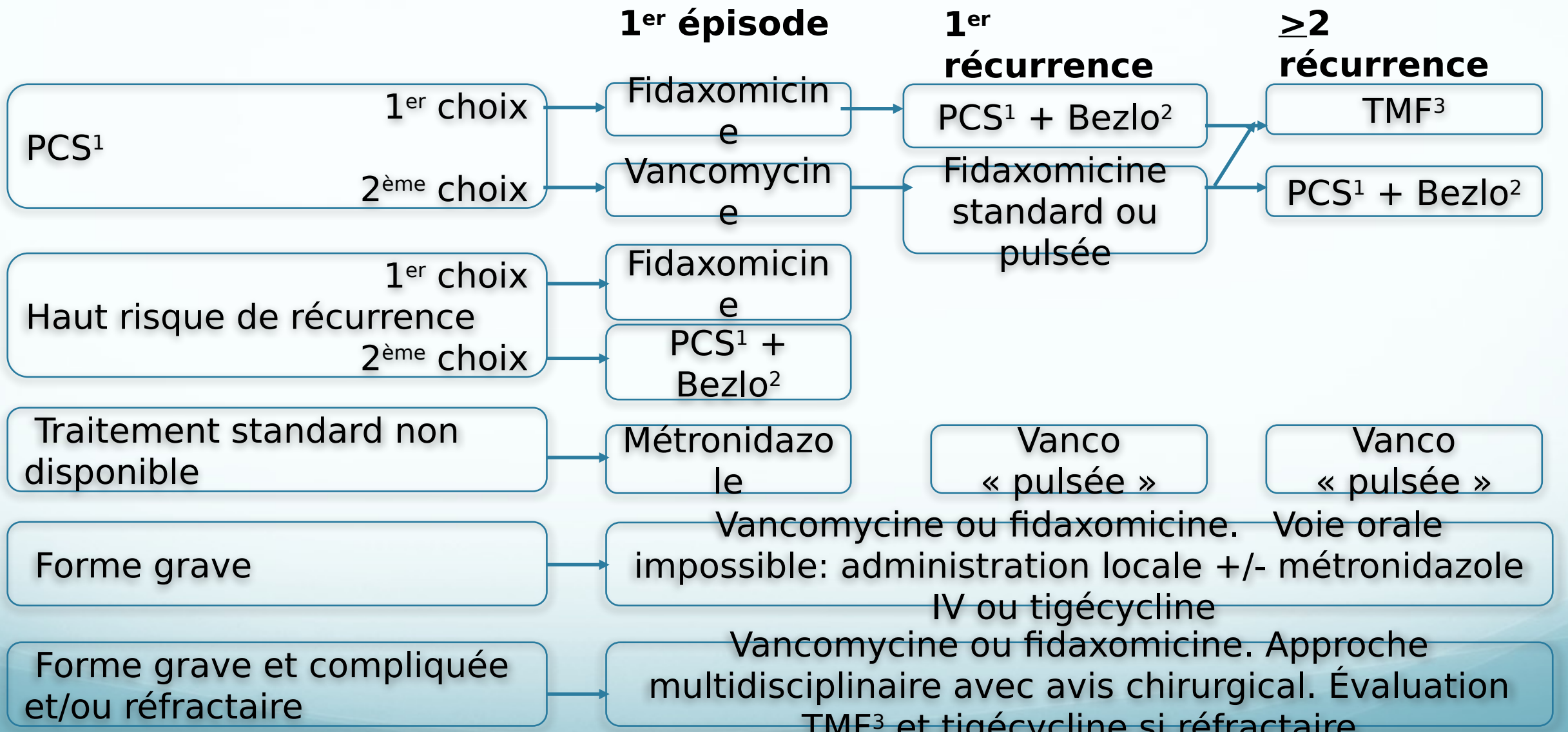
Facteurs pronostiques associés au risque de récurrence

	Niveau d'évidence
Age ≥ 65 ans	Fort, modéré
Episode antérieur d'infection à *C. difficile*	Fort, modéré
Episode lié aux soins et hospitalisation dans les 3 derniers mois	Faible, bas
Antibiothérapie systémique concomitante après le diagnostic	Faible, très bas
Traitement par IPP pendant ou au décours du diagnostic	Faible, très bas

Mesures générales

- Arrêt d’une antibiothérapie quand elle n’est pas nécessaire
- Rééquilibration hydro-électrolytique
- Pas de ralentisseurs du transit
- Discuter l’arrêt du traitement par IPP

Algorithme de prise en charge



[1] Prise en charge standard ; [2] Bezlotoxumab ; [3] Transplantation microbiote fécal

Posologies des molécules utilisées

Molécule	Dosage recommandé	Voie
Fidaxomicine	200 mg/12 h qsp 10j	Per os
Fidaxomicine pulsée	200 mg/12 h qsp de J1 à J5, puis 200 mg toutes les 48h de J7 à J25	Per os
Vancomycine	125 mg/6 h qsp 10j	Per os
Vancomycine pulsée	125 mg/6 h qsp 14j, puis 125 mg/12 h qsp 7j, puis 125 mg/24 h qsp 7j, puis 125 mg toutes les 48 h qsp 7j, puis 125 mg toutes les 72 h qsp 7j	Per os
Bezlotoxumab	10 mg/kg sur 1h, dose unique	I.V.
Métronidazole	500 mg/8 h qsp 10j	Per os
	500 mg 8/h qsp 10j	I.V.
Tigécycline	Charge 100 mg puis 50 mg/12h	I.V.

Remarques

- Le métronidazole n’est plus recommandé comme antibiotique de première ligne dans les infections à *C. difficile*
- Il n’existe pas de données suffisantes pour argumenter l’utilisation de hautes doses de vancomycine
- L’utilisation de la fidaxomicine pulsée peut être proposée chez les patients âgés à haut risque de récidive
- Aucune prophylaxie médicamenteuse, y compris par probiotiques, n’est recommandée.